

Marzo confirma el problema del año

El mes cerró en -\$150M y el acumulado deja -\$122M tras 3 meses, contra \$379M del año pasado. El ingreso creció 46,6% y el resultado no lo siguió.

\$1.623M

▲ 60,0%

Ingreso de marzo

-\$150M

▼ 229,0%

Resultado del mes

\$4.363M

▲ 46,6%

Ingreso acumulado · ene-mar

-\$122M

▼ 132,2%

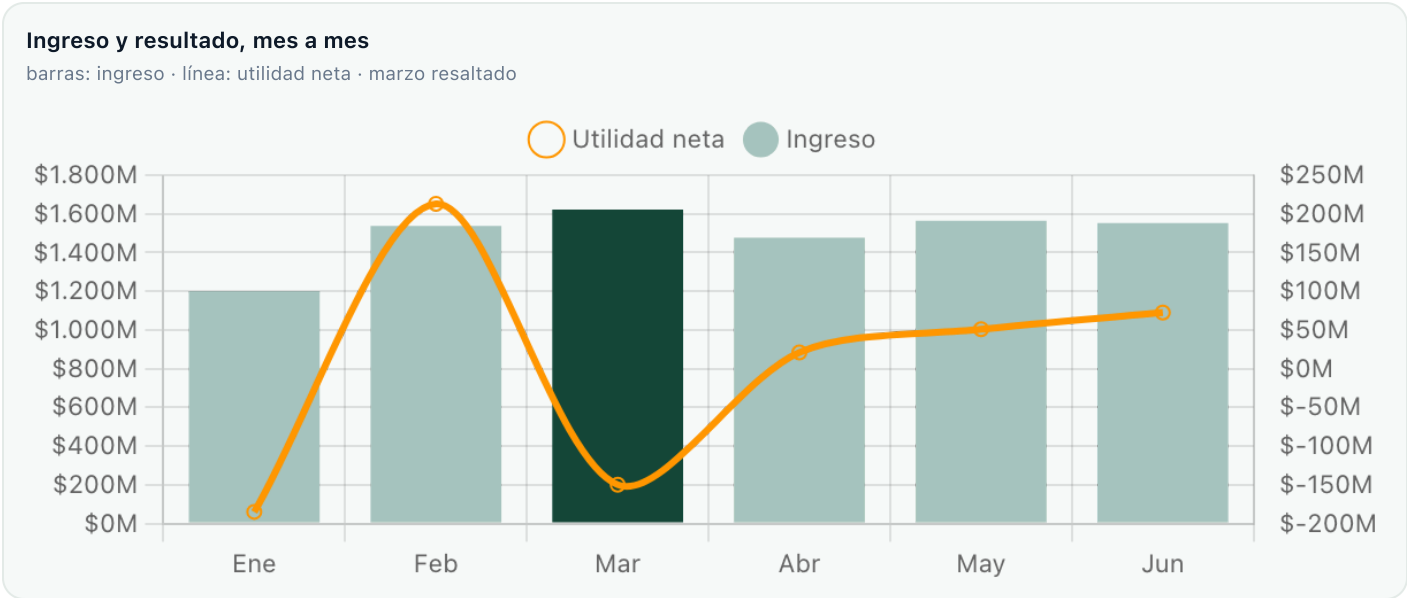
Resultado acumulado

Hay una escena que resume el año mejor que cualquier tabla: el quirófano lleno y la utilidad que no aparece. En marzo entraron \$1.623M —el mejor marzo del que se tenga registro— y el mes cerró con -\$150M. Pero al mirar los seis meses juntos, el ingreso creció 46,6% y la utilidad acumulada quedó en -\$122M: 132,2% por debajo de la del año pasado.

La pregunta, entonces, no es si el negocio está creciendo —lo está, y rápido—. La pregunta es por qué ese crecimiento no está llegando abajo. Este informe recorre esa distancia: de dónde vino el ingreso, en qué se fue, quién opera, quién paga y cuánta sala se está usando de la que ya se paga —hoy el 36,4%—. La conclusión está al final, pero se adelanta acá: el problema no es de demanda.

Qué pasó en el mes

El ingreso de marzo fue \$1.623M, que subió 60,0% frente al mismo mes de 2025. El costo directo se movió en la misma dirección pero con otra fuerza: \$1.117M, 90,4% más que hace un año, lo que dejó una utilidad bruta de \$506M — un margen de 31,2%. Después de la estructura, el mes cerró con -\$150M de utilidad neta, frente a \$213M del mes anterior.

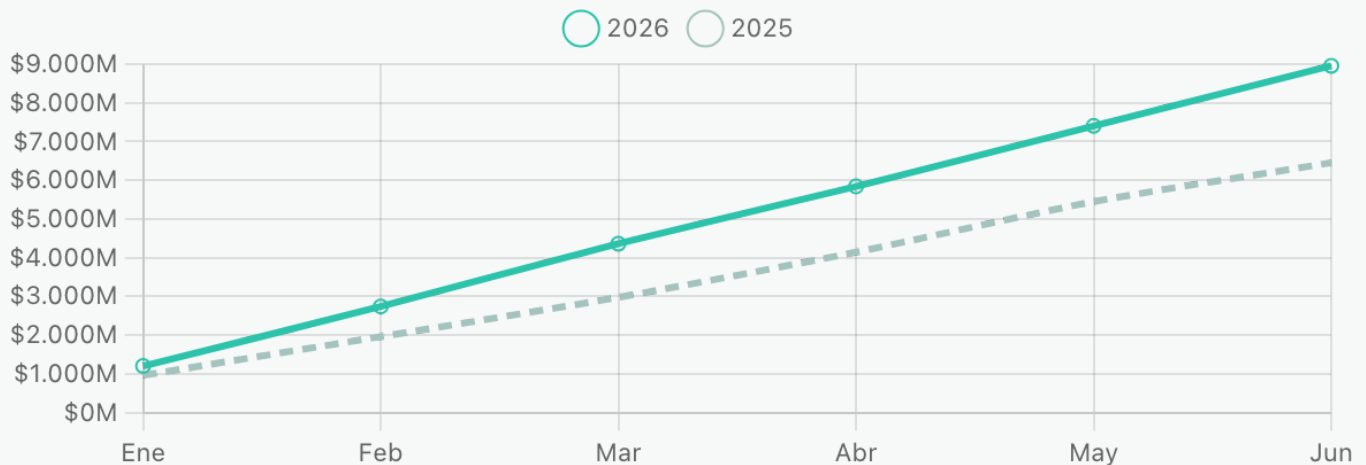


Cómo va el año

En los primeros 3 meses el ingreso acumulado llega a \$4.363M, 46,6% por encima de los \$2.976M del mismo período de 2025. La utilidad acumulada es -\$122M contra \$379M: una caída de 132,2%. El margen neto del año va en -2,8%, y el EBITDA acumulado en \$128M.

Acumulado 2026 contra 2025

suma corrida del ingreso, mes a mes

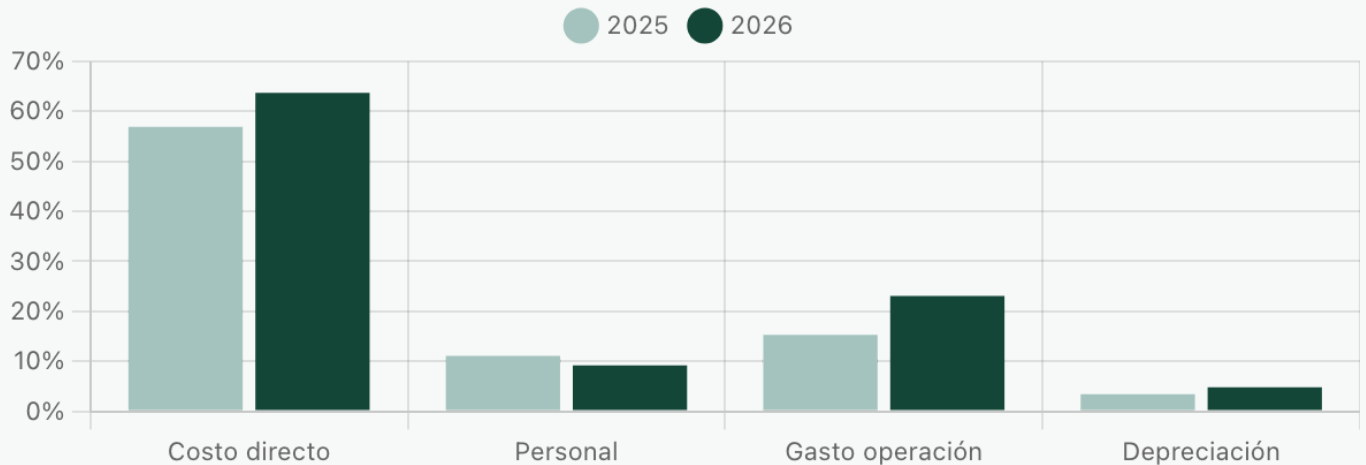


De dónde salió el resultado

De cada cien pesos que entraron en el año, 64 se fueron en costo directo, contra 57 del año pasado: una pérdida de 6.8 puntos de margen. La estructura —personal, gasto de operación y depreciación— sumó \$1.621M en el acumulado, de los cuales \$401M son personal y \$212M depreciación. Es ahí, y no en el volumen, donde se define si el crecimiento llega abajo.

A dónde va cada cien pesos de ingreso

acumulado ene-mar, 2025 contra 2026

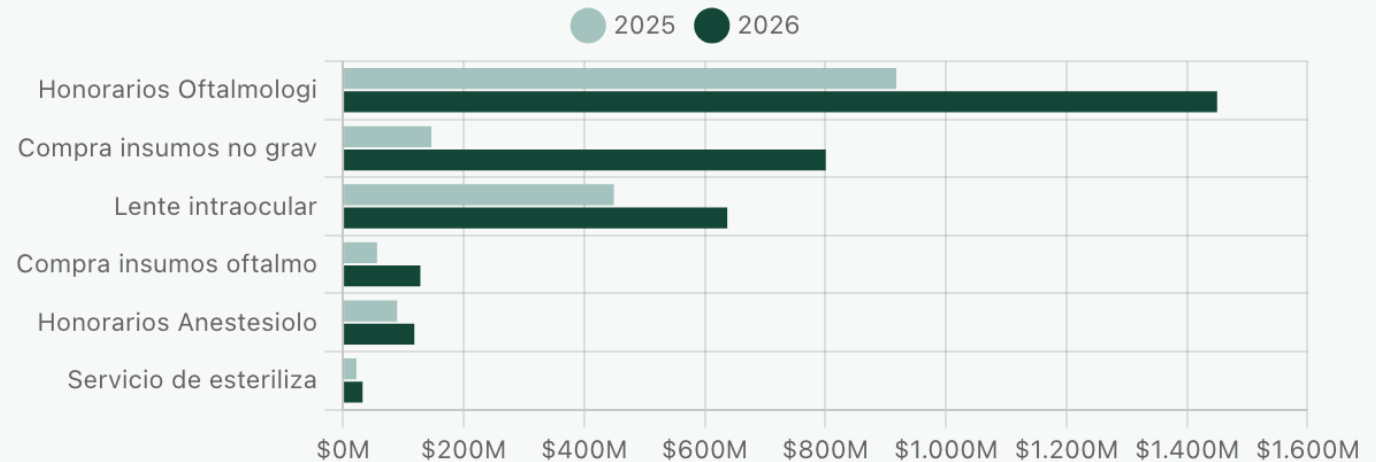


El costo directo, por dentro

En el acumulado el costo directo suma \$2.780M y se reparte en tres bloques: honorarios oftalmología \$1.450M (46% del costo); compra insumos no gravados \$801M (25% del costo); lente intraocular \$637M (20% del costo). Los honorarios son el rubro que manda —46% del costo— y se mueven con el volumen, así que su crecimiento no es en sí una señal; lo que hay que mirar es si crecen MÁS rápido que el ingreso. El lente intraocular pesa \$637M y los insumos \$801M: son los dos rubros donde una negociación de tarifa se ve en el mes siguiente.

El costo directo, cuenta por cuenta

acumulado ene-mar · en millones

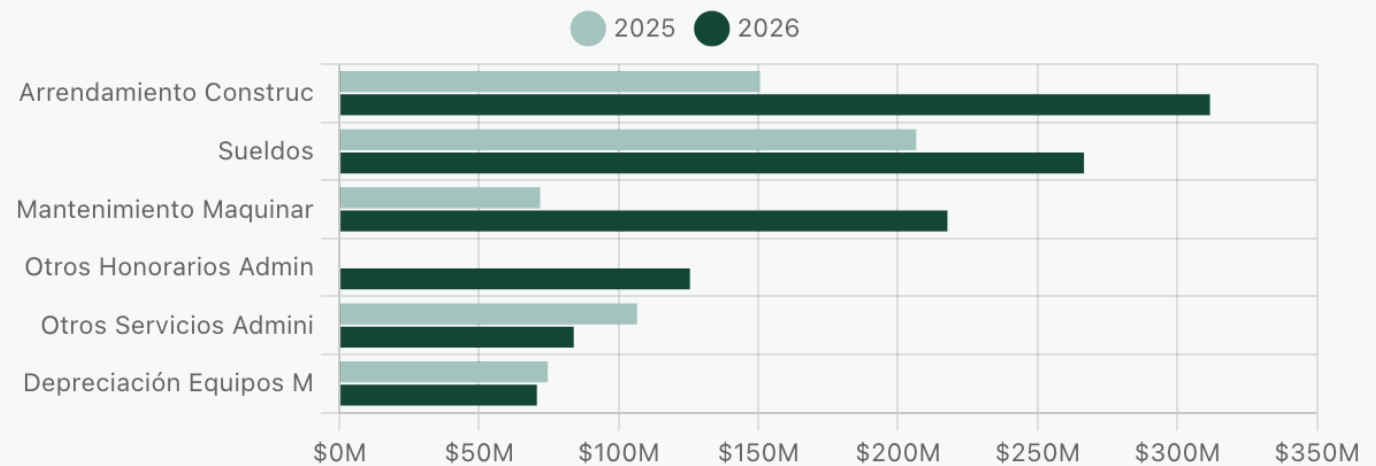


El gasto de estructura

La estructura acumulada suma \$1.621M, que es 37,2% del ingreso del año. Los cuatro rubros que la explican son arrendamiento construcciones y edificaciones administración \$312M; sueldos \$267M; mantenimiento maquinaria y equipo administración \$218M; otros honorarios administración \$126M. A diferencia del costo directo, esta base no se mueve con el volumen: es la que determina cuántas cirugías hacen falta para que el mes cierre en positivo. Por eso llenar quirófano tiene un efecto tan directo — cada procedimiento adicional entra sobre una estructura ya pagada.

El gasto de estructura

los rubros que más pesan · acumulado ene-mar

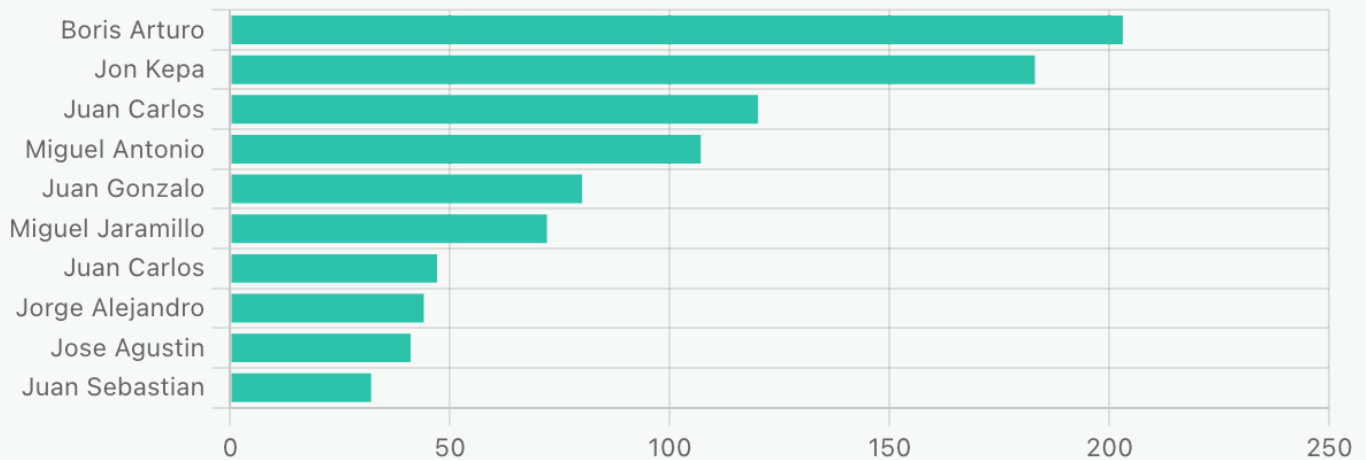


Quién opera, y con qué peso

42 cirujanos operaron en lo corrido del año, y los cinco primeros concentran 59% de las cirugías. Pero el ranking cambia según cómo se mire, y esa diferencia es el dato: por número de cirugías encabeza Boris Arturo Ramirez con 203; por horas de quirófano encabeza Jon Kepa Balparda con 71 horas. Un cirujano refractivo hace muchos procedimientos de veinte minutos y otro hace pocos de dos horas: cuentan distinto en la agenda, en el consumo de sala y en el resultado. Medir solo por conteo premia al primero y esconde cuánta capacidad consume el segundo.

Los cirujanos que mueven el volumen

procedimientos en el año · los diez primeros

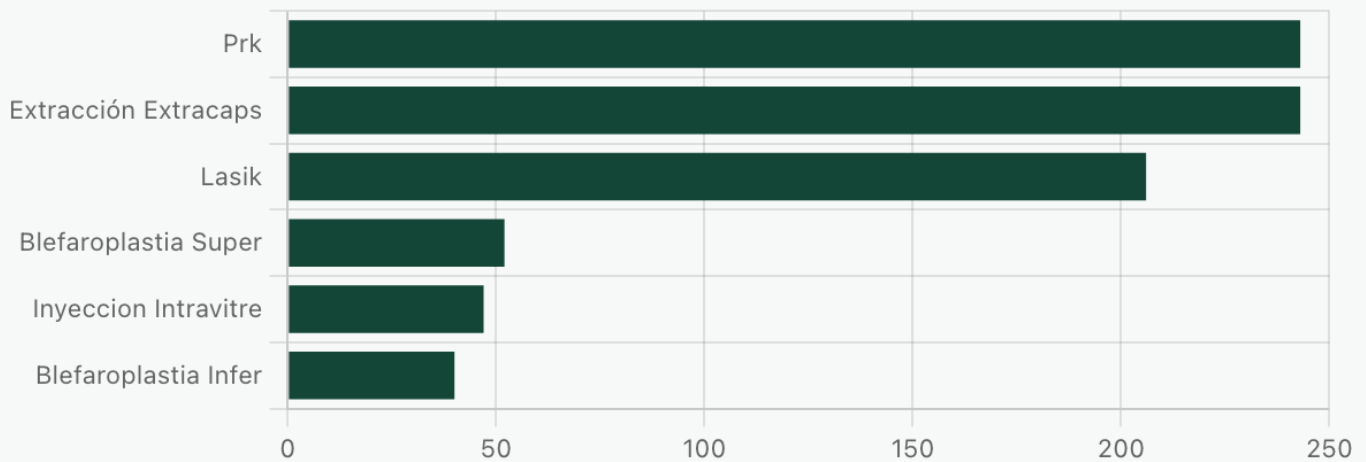


Qué se opera y con qué lente

La mezcla del año la encabezan prk 243 (\$0,9M por procedimiento); extracción extracapsular a 243 (\$2,9M por procedimiento); lasik 206 (\$0,9M por procedimiento). La diferencia de tarifa entre procedimientos es lo que hace que dos meses con el mismo número de cirugías dejen resultados distintos. En cuanto a lentes, se facturaron 273 unidades por \$741M, sobre 1.172 derechos de sala: una penetración de 20%. El lente es a la vez ingreso y costo, así que su margen depende de la tarifa negociada, no del volumen.

Qué se opera

procedimientos del año por tipo · los seis primeros

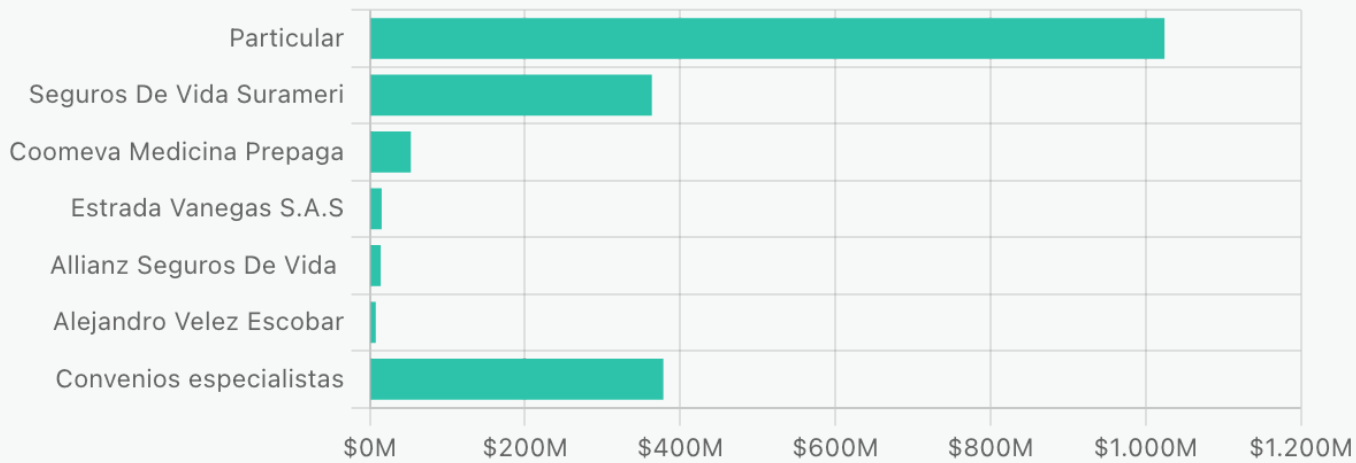


Quién paga

De los \$1.887M facturados en derechos de sala este año, el reparto por pagador es: Particular 54%; Seguros De Vida Suramericana S 19%; Coomeva Medicina Prepagada S.A 3%; Estrada Vanegas S.A.S 1%. El paciente particular pesa 54% del ingreso de sala, que es la porción que no depende de tarifa negociada ni de autorización previa — y por eso es la más rentable y la más volátil a la vez. La concentración en pocos pagadores define el poder de negociación: cuando una sola entidad pesa más de un tercio, la renegociación de su tarifa deja de ser un trámite y pasa a ser un evento de resultado.

Quién paga los derechos de sala

acumulado ene-mar · participación del ingreso



La capacidad que no se usa

Los tres espacios quirúrgicos operaron al 36,4% de su capacidad en lo corrido del año: 838 horas reservadas de 2.301 disponibles, dejando 1.462 horas de sala que se pagan y no producen. La medición es por espacio reservado —la sala se aparta en bloques y si la cirugía termina antes ese tiempo ya no se vende—, con la ventana de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 y sábados hasta las 12:00. El mapa de abajo muestra dónde está el hueco: cada celda es una hora de un día de la semana, en verde lo disponible y en rojo lo ocupado.

Dónde está la sala libre

cada celda es una hora de un día · verde disponible, rojo ocupada · promedio del año

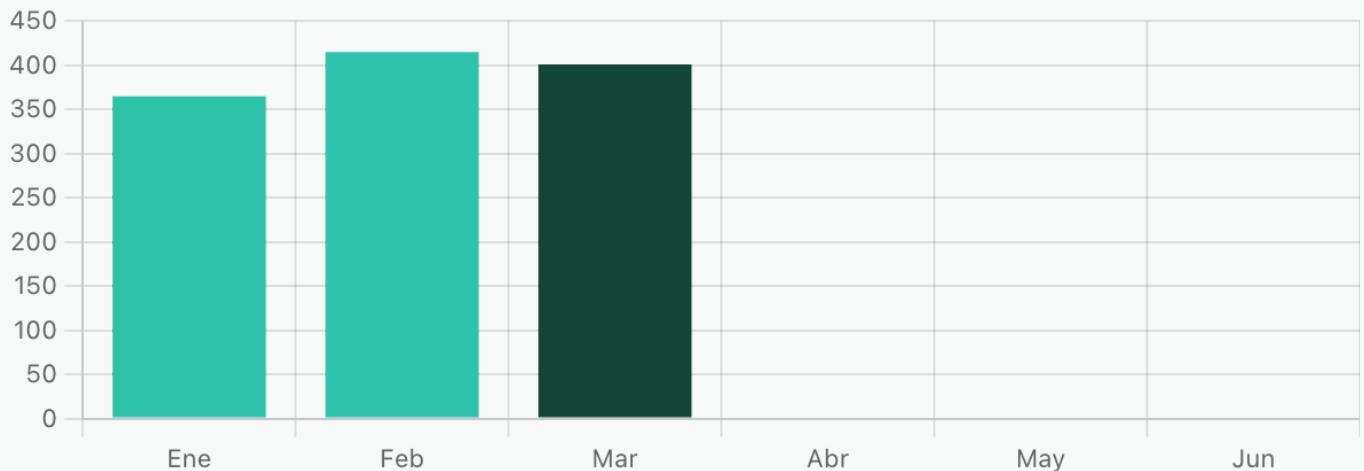
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lun	24	26	30	29	29	30	18	24	34	33	26	17
Mar	8	18	36	38	32	20	28	36	40	48	42	28
Mié	19	29	36	31	42	27	25	40	37	25	20	11
Jue	28	51	55	48	46	35	28	40	56	48	54	22
Vie	46	58	55	48	42	40	35	54	49	39	42	23
Sáb	38	59	60	48	43							

La operación

En marzo se realizaron 401 procedimientos, 41,7% más que en marzo de 2025, y 1.172 en lo corrido del año. El ingreso por procedimiento del mes fue \$4,0M. La lectura útil no es solo cuántos se hicieron sino a qué tarifa: si el volumen sube y el ingreso por procedimiento baja, el crecimiento se está comprando con precio.

Cirugías por mes

cirugías únicas · fuente: agenda quirúrgica



Qué hay que decidir

El costo directo gana margen

Pesa 6.8 puntos más del ingreso que el año pasado. Sobre el acumulado de \$4.363M, cada punto son \$44M. Definir si es mezcla de procedimientos, tarifa de insumos o ambos.

El crecimiento no llega abajo

El ingreso creció 46,6% y la utilidad cayó 132,2%. Es el hallazgo del año: se está operando más grande para ganar lo mismo o menos.

Conclusiones

El margen se está yendo por el costo directo, no por el gasto

El costo directo pasó de 56,9% a 63,7% del ingreso. Sobre el acumulado de \$4.363M, esos 6.8 puntos son \$297M que dejaron de bajar al resultado. Como el rubro que manda son los honorarios y esos siguen al volumen, la palanca no es recortarlos sino revisar la tarifa de los dos que sí se negocian: lente e insumos.

Hay un negocio entero dentro del que ya existe

Las salas operan al 36,4% de su capacidad y quedan 1.462 horas al año que se pagan igual. No hace falta obra ni equipos: hace falta agenda. Cada hora que se llena entra sobre una estructura de \$1.621M que ya está causada, así que su efecto en el resultado es casi directo.

La agenda depende de pocas manos

Cinco cirujanos concentran 59% de las cirugías del año. Eso no es un problema hoy, pero sí una dependencia: vale la pena saber qué pasa con el mes si uno de ellos para dos semanas, y tener la respuesta antes de necesitarla.

Qué mirar el mes entrante

Tres cifras, en este orden: el costo directo como porcentaje del ingreso —hoy 63,7%—, la ocupación de sala —hoy 36,4%— y el ingreso por cirugía. Si las tres se mueven en la dirección correcta, el resultado llega solo. Si el ingreso crece y esas tres no se mueven, el mes siguiente se parecerá a este.

Las cifras, para verificar

RUBRO	MAR 2026	MAR 2025	ACUM. 2026	ACUM. 2025
Ingreso	\$1.623M	\$1.014M	\$4.363M	\$2.976M
Costo directo	\$1.117M	\$587M	\$2.780M	\$1.694M
Utilidad bruta	\$506M	\$428M	\$1.582M	\$1.282M
Personal	\$151M	\$122M	\$401M	\$330M
Gasto de operación	\$408M	\$161M	\$1.008M	\$457M
Depreciación	\$73M	\$34M	\$212M	\$101M
EBIT	-\$126M	\$111M	-\$39M	\$395M
EBITDA	-\$77M	\$155M	\$128M	\$496M
Utilidad neta	-\$150M	\$116M	-\$122M	\$379M